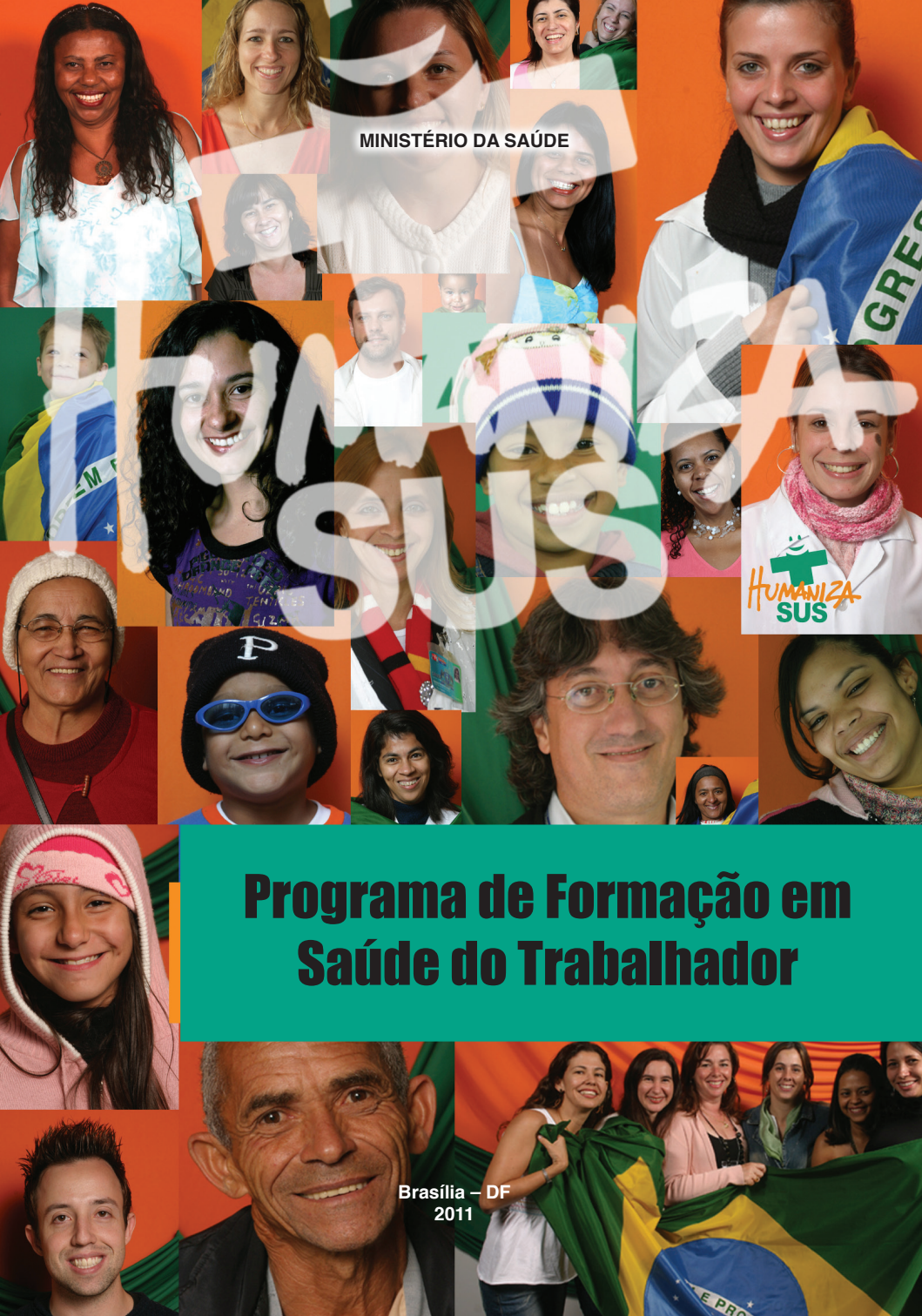


Programa de Formação em Saúde do Trabalhador

Brasília – DF
2011

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria de Atenção à Saúde
Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS



Programa de Formação em Saúde do Trabalhador

Série B. Textos Básicos de Saúde

Editora MS

Brasília – DF
2011

© 2011 Ministério da Saúde.
Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial. A responsabilidade pelos direitos autorais de textos e imagens desta obra é da área técnica. A coleção institucional do Ministério da Saúde pode ser acessada, na íntegra, na Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde: http://www.saude.gov.br/bvs.

Tiragem: 1ª edição – 2011 – 1.000 exemplares

Elaboração, distribuição e informações:
MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria de Atenção à Saúde
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas
Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS
SAF Sul, trecho 2, bloco F, 1º andar, sala 102, Ed. Premium, torre II.
CEP: 70070-600, Brasília – DF
Tel.: (61) 3306-8130
Fax: (61) 3306-8131
E-mail: humanizasus@saude.gov.br
Home pages: www.saude.gov.br/humanizasus
www.redehumanizasus.net

Elaboração de texto:
Maria Elizabeth Barros de Barros
Maria Elizabeth Mori
Fernanda Beck
Fábio Hebert
Maria Edna Moura
Rafael Silveira Gomes
Serafim Santos-Filho

Editora MS
Coordenação de Gestão Editorial
SIA, trecho 4, lotes 540/610
CEP: 71200-040, Brasília – DF
Tels.: (61) 3233-1774 / 2020
Fax: (61) 3233-9558
E-mail: editora.ms@saude.gov.br
Home page: http://www.saude.gov.br/editora

Normalização: Amanda Soares Moreira
Revisão: Julio Maria de Oliveira Cerqueira
Capa, projeto gráfico e diagramação: Marcus Monici e Alisson Sbrana

Impresso no Brasil / *Printed in Brazil*

Ficha Catalográfica

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS.
Programa de formação em saúde do trabalhador / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS. – Brasília : Ministério da Saúde, 2011.
44 p. : il. – (Série B. Textos Básicos de Saúde)

ISBN 978-85-334-1838-7

1. Humanização. 2. Política Nacional de Humanização. 3. Gestão do trabalho no SUS. I. Título. II. Série.

CDU 616-051

Catalogação na fonte – Coordenação-Geral de Documentação e Informação – Editora MS – OS 2011/0025

Títulos para indexação:
Em inglês: Training program in occupational health
Em espanhol: Programa de capacitación en salud ocupacional

Sumário

APRESENTAÇÃO 05

1 AS SUTILEZAS DOS PROCESSOS DE GRUPO 08

2 SAÚDE – DO QUE SE TRATA? 14

3 TRABALHO E GESTÃO 22

4 AS COMUNIDADES AMPLIADAS DE PESQUISA (CAP) 35

APRESENTAÇÃO

Caderno de Textos – PFST/PNH

PNH e trabalho? Que história é essa?

A Política Nacional de Humanização (PNH) implementada pelo Ministério da Saúde se propõe como uma construção coletiva que tem como objetivo transformar, com os diferentes sujeitos que constituem o sistema de saúde – gestores, usuários e trabalhadores – as relações e os modos de agir e produzir saúde no SUS.

A PNH nega qualquer entendimento do humano como "Homem" idealizado, como um modelo de "Homem" a ser perseguido, consequentemente, não entende a humanização como uma tentativa de aproximar os diferentes sujeitos desse ideal. A humanização deve se dar nas práticas e a partir delas, ou seja, lidando, cotidianamente, com as relações que estabelecemos e os seus efeitos em nossa vida cotidiana. A PNH é o coletivo de homens e mulheres comuns que compõem o SUS em suas experiências concretas, são os trabalhadores e usuários que habitam o dia a dia dos serviços de saúde. Somente no encontro entre estes sujeitos concretos que práticas que chamamos de "humanizadoras" podem acontecer. Uma prática humanizadora acontece mediante o entendimento e a abertura ao outro (trabalhador, usuário ou gestor) como legítimo na relação que se produz, quando consideramos suas características, suas diversas formas de ser, seus saberes, seus desejos e suas necessidades em nossas

ações. Assim, a PNH afirma todos os sujeitos do SUS como protagonistas e corresponsáveis pela produção da saúde e combatendo qualquer relação de tutela, desrespeito ou desqualificação do outro.

Dispositivo: outros modos de fazer são possíveis

Como política pública a PNH propõe princípios e diretrizes éticos que atravessam e sustentam nossa aposta em um SUS que dá certo, rompendo com algumas fronteiras e práticas rígidas e adoecedoras. Transformando os modos de agir no conjunto das relações que constituem o SUS, podemos produzir novos sujeitos para novas práticas de saúde (PASSOS; BENEVIDES, 2007).

Valorizar o trabalho e a saúde do trabalhador são diretrizes fundamentais para que os princípios propostos pela PNH se atualizem nos serviços e nas relações de trabalho. Produzindo novos modos de trabalhar e de viver mais saudáveis e prazerosos potencializamos o protagonismo dos trabalhadores. E protagonismo implica a corresponsabilidade e a existência de espaços para construirmos outros modos de trabalhar (dispositivos) e instrumentos avaliativos (desses novos modos de trabalhar), a fim de se promover saúde e melhores condições de trabalho, afinal ninguém melhor que os trabalhadores para falar sobre o seu trabalho e a sua saúde, não é mesmo?

Se concordamos que há uma aposta atravessando nossas afirmações até aqui, podemos com isso dizer que essa aposta se concretiza no modo como o trabalho acontece. A problematização dos processos de trabalho está totalmente colocada quando pensamos os dispositivos. A análise coletiva dos processos de trabalho e os dispositivos são indissociáveis, pois não é possível pensar em intervenção na direção da PNH, ou seja, na **mudança dos modos de gestão e de cuidado**, se não operamos uma radical torção nos modos de organizar o trabalho.

PFST: mais uma sigla? Para que compartilhar experiências?

O Programa de Formação em Saúde e Trabalho (PFST) apresenta-se como um dispositivo da PNH que tem como objetivo promover um espaço de formação fundado no diálogo permanente. No diálogo entre os diferentes trabalhadores e no diálogo entre os distintos saberes. Saberes da experiência, produzidos pelos trabalhadores no serviço cotidianamente e os saberes formais, provenientes da academia, por exemplo. Como podemos construir coletivamente modos de fazer isso no concreto das experiências, nos serviços?

Pensar essa questão juntos é a direção que esta proposta de formação pretende seguir, de modo que possamos incorporar ao nosso fazer cotidiano, isso que estamos chamando de análise coletiva do trabalho.

Essa direção que aponta para um maior diálogo dos saberes (experiência e conceito) no PFST pode potencializar um trabalho nos serviços do SUS mais saudável e produzir momentos de aprendizagem coletiva, uma vez que permitem a construção de ferramentas de análise das condições geradoras de sofrimento e adoecimento.

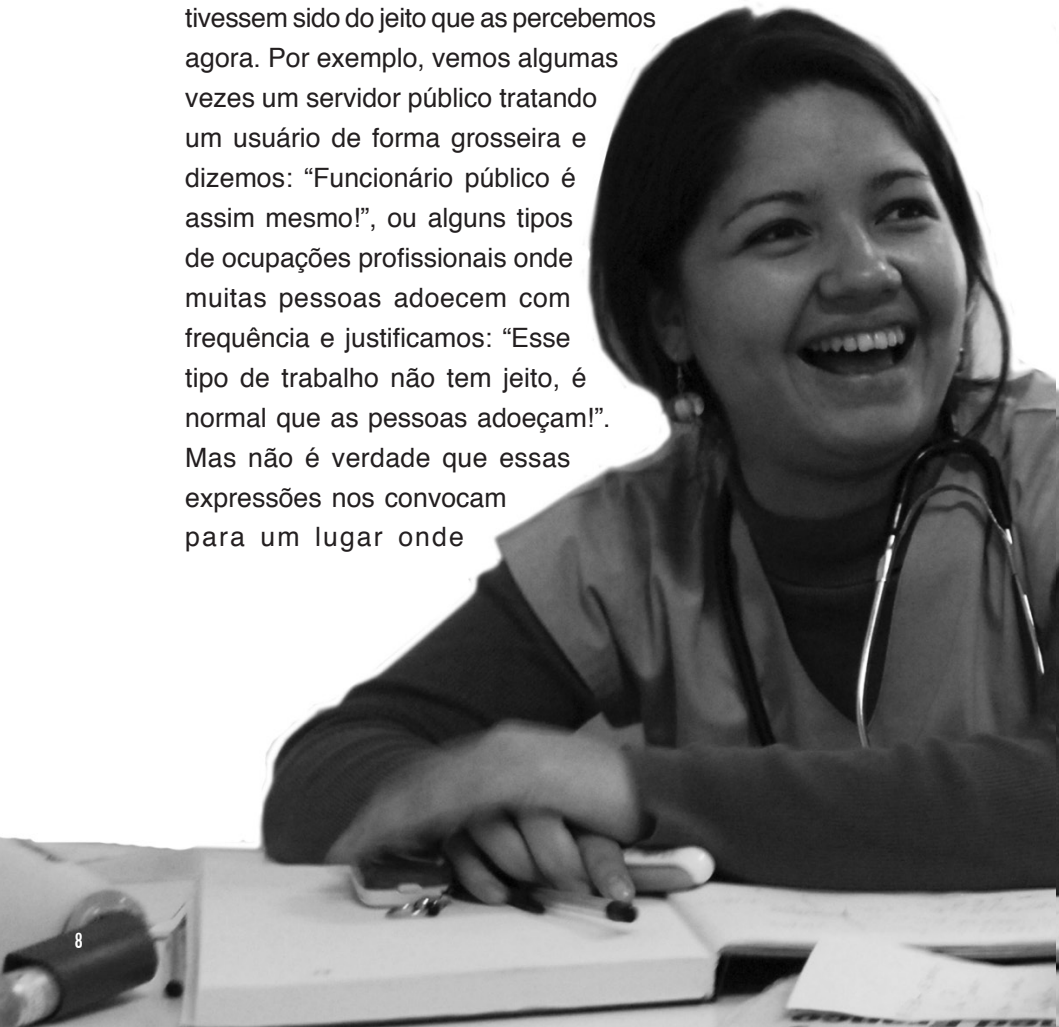
Este caderno de textos se constitui como uma ferramenta, ou melhor, como uma caixa de ferramentas conceituais que se propõe a ser uma força a mais na criação de um terreno comum (uma política pública em nome e ação) onde possamos dialogar e pensar relações menos adoecedoras. Ferramentas que devem ser compartilhadas, discutidas e transformadas coletivamente. Como e quando usá-las dependerá de nossa capacidade coletiva de habitar esse terreno comum a partir de nossas experiências (e desafios) regionais.

Mãos à obra!!!

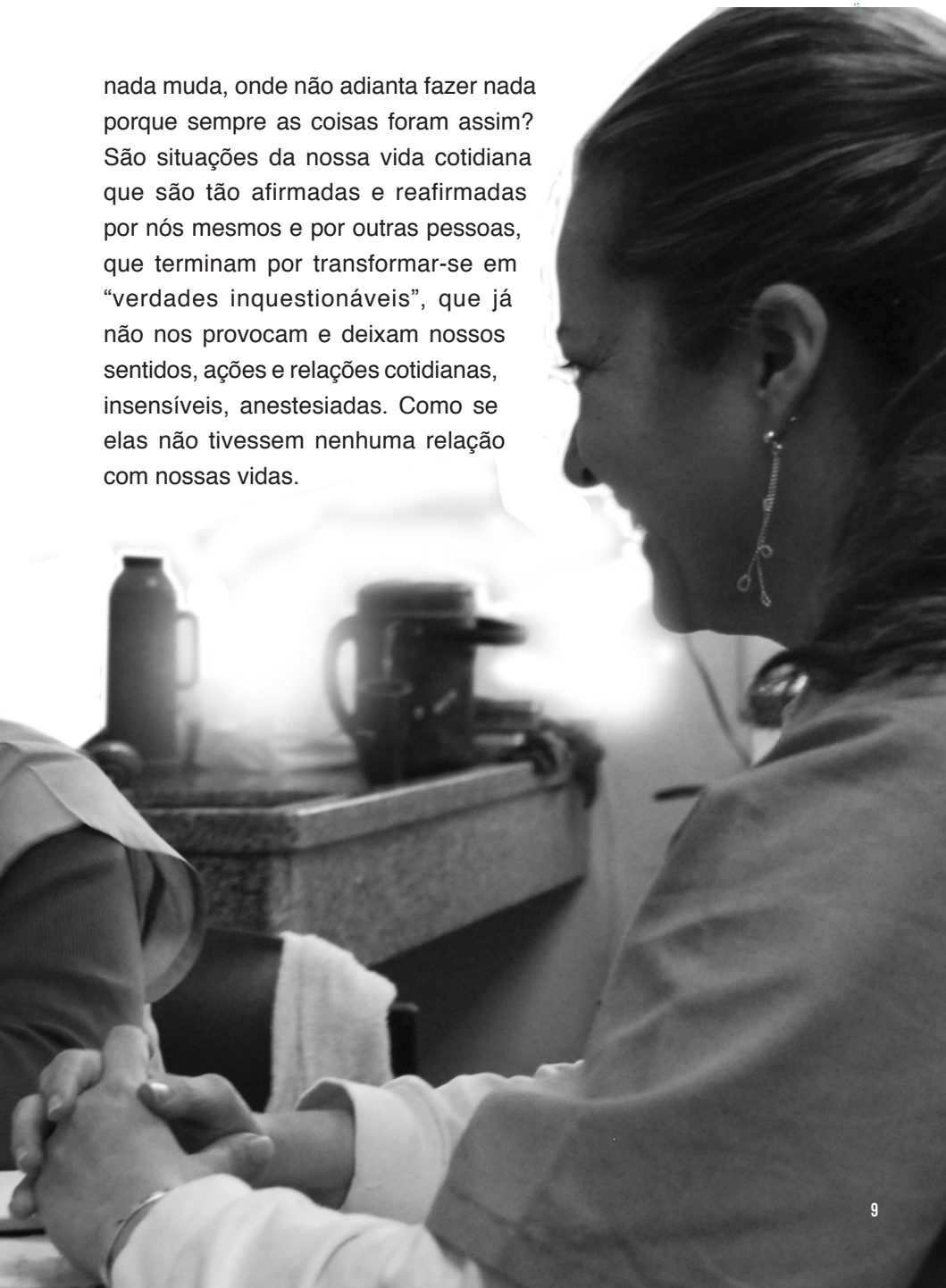
1 AS SUTILEZAS DOS PROCESSOS DE GRUPO

As coisas sempre foram assim como as encontramos? Ou existem outros modos de ver e entender o mundo?

Normalmente vivemos muitas situações como se elas fossem "naturais", ou como se as coisas sempre tivessem sido do jeito que as percebemos agora. Por exemplo, vemos algumas vezes um servidor público tratando um usuário de forma grosseira e dizemos: "Funcionário público é assim mesmo!", ou alguns tipos de ocupações profissionais onde muitas pessoas adoecem com frequência e justificamos: "Esse tipo de trabalho não tem jeito, é normal que as pessoas adoeçam!". Mas não é verdade que essas expressões nos convocam para um lugar onde



nada muda, onde não adianta fazer nada porque sempre as coisas foram assim? São situações da nossa vida cotidiana que são tão afirmadas e reafirmadas por nós mesmos e por outras pessoas, que terminam por transformar-se em "verdades inquestionáveis", que já não nos provocam e deixam nossos sentidos, ações e relações cotidianas, insensíveis, anestesiadas. Como se elas não tivessem nenhuma relação com nossas vidas.



É natural em nosso convívio, por exemplo, chamar de "grupo" um conjunto de pessoas reunidas com objetivos comuns e/ou afinidades, que mantém uma estabilidade por um tempo e em um determinado lugar. Mas, não é verdade que vivemos (participamos de) inúmeros grupos em nossa vida cotidiana que estão repletos de conflitos e de confusões, além de toda a afinidade?

Parece que, na maneira mais tradicional, mais comum, de se ver o grupo, as pessoas perdem sua 'individualidade' quando inseridas em grupos. Existe aí uma ideia de unidade, de totalidade, como se para formar um grupo tivéssemos que pensar e sentir todos da mesma forma. Isso é possível?

Num outro olhar...

Podemos também pensar o "grupo" como um **caminho** ou um terreno (acidentado por vezes) onde experimentamos afetos, expressamos saberes, falamos, ouvimos, vivemos conflitos... Caminho que não pretende nem promete acabar com os problemas, mas nos ajuda a, junto com os outros, pensarmos e encararmos os problemas de outra forma, de modo que não seja responsabilidade de uma única pessoa. A responsabilidade pode ser compartilhada e pode ser que fique mais "leve" viver os problemas não como responsabilidade pessoal, mas como um compartilhar experiências. O grupo pode ser um caminho que favorece a

experimentação de outros modos de viver ou que possibilita que outras coisas possam acontecer.

Mas será que simplesmente juntar pessoas garante a existência de um "grupo" ou da corresponsabilização pelos desafios que atravessamos?

Em nosso trabalho, por exemplo, que tipo de "grupo" temos experimentado? Quais os efeitos desses "grupos" em nossa vida cotidiana?

Normalmente, não vemos sobrar tempo ou espaço para discussões sobre os modos como temos nos organizado para trabalhar. As pessoas acabam se organizando em "equipes", que são "responsáveis" e "culpadas" pelo êxito ou fracasso dos resultados do trabalho.

Apostamos que o grupo pode se constituir como uma estratégia e "dispositivo" de criação e experimentação de outros modos de expressão, diferentes dos grupos que buscam o equilíbrio ou as verdades inquestionáveis.

Nesse exercício, não sabemos e nem controlamos o quanto podemos afetar e sermos afetados; tudo é uma questão de experimentação, que vai constituindo o mundo em que vivemos.

Para poder construir esse outro "grupo" (que é a nossa aposta), é preciso questionar, em primeiro lugar, o que nossas ações e nossas formas de enfrentamentos cotidianos têm produzido, para então buscarmos outro caminho, que aponte para a direção da invenção coletiva de alternativas aos processos com os quais estamos tão acostumados.

O que queremos construir coletivamente? O que desejamos? Como constituir grupos que não funcionem apenas para manter o que já está aí? Como construir grupos que sejam um jeito de mudar o que nos faz mal?

Existe uma “falta de tempo” e uma descrença nas possibilidades de criação de práticas diferentes das que conhecemos. Parece que não acreditamos na possibilidade de formarmos grupos para mudar: mudar o jeito de trabalhar, o jeito de ser mulher, de ser homem, de ser profissional da saúde, mudar... ousar a mudança que desejamos.

Como aquecimento para iniciarmos a discussão sobre as questões acima, apresentamos um pequeno texto do escritor Franz Kafka, chamado Comunidade.

> Somos cinco amigos, certa vez saímos um atrás do outro de uma casa, logo de início saiu o primeiro e se pôs ao lado do portão da rua, depois saiu o segundo, ou melhor: deslizou leve como uma bolinha de mercúrio, pela porta, e se colocou não muito distante do primeiro, depois o terceiro, em seguida o quarto, depois o quinto. No fim, estávamos todos formando uma fila, em pé. As pessoas voltaram a atenção para nós, apontaram-nos e disseram: “Os cinco acabam de sair daquela casa”. Desde então vivemos juntos; seria uma vida pacífica se um sexto não se imiscuísse sempre. Ele não nos faz nada, mas nos aborrece, e isso basta: por que é que ele se intromete à força onde não querem saber dele? Não o conhecemos e não queremos acolhê-lo. Nós cinco também não nos conhecíamos antes e, se quiserem, ainda agora não nos conhecemos um ao outro; mas o que entre nós cinco é possível e tolerado não o é com o sexto. Além do mais somos cinco e não queremos ser seis. E se é que esse estar junto constante tem algum sentido, para nós cinco não tem, mas agora já estamos

> reunidos e vamos ficar assim; não queremos, porém, uma nova união justamente com base nas nossas experiências. Mas como é possível tornar tudo isso claro ao sexto? Longas explicações significariam, em nosso círculo, quase uma acolhida, por isso preferimos não explicar nada e não o acolhemos. Por mais que ele torça os lábios, nós o repelimos com o cotovelo; no entanto, por mais que o afastemos, ele volta sempre (KAFKA, 2002, p. 112-113).

É importante estar junto para enfrentar os problemas cotidianos? O modo como estamos juntos está incluindo os problemas? De que coletivo estamos falando? O que é trabalhar em grupo? Quais as desvantagens ou vantagens de pensarmos e avaliarmos o trabalho solitariamente?

Fica o desafio:

Será que podemos inventar outras práticas grupais que permitam a criação coletiva de alternativas aos processos que hoje adoecem?

Como você pensa a possibilidade de constituir 'grupos-dispositivos' na unidade onde trabalha...

Referências

BARROS, Regina Benevides de. **Grupo**: afirmação de um simulacro. Porto Alegre: Editora UFEGS; Sulina, 2007.

KAFKA, Franz. **Narrativas do espólio** (comunidade). Tradução e posfácio: Modesto Carone. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.

OLIVEIRA, S. P. et al. As sutilezas dos processos de grupo e formação na atualidade. In: ATHAYDE, Milton et al. (Orgs.). **Trabalhar na escola?**: só inventando o prazer. Rio de Janeiro: IPU&B, 2001. v. 1, p. 91-102.

2 SAÚDE – DO QUE SE TRATA?

Normalmente nos preocupamos com a nossa saúde quando percebemos que alguma coisa em nosso corpo não está funcionando como antes e esse novo funcionamento nos atrapalha em nossas atividades diárias. Mas também não é verdade que muitas vezes percebemos que algo não está funcionando como antes, mesmo antes de adoecermos? É muito comum, por exemplo, sentirmos mal-estar e dores pelo corpo e dizermos, “Acho que vou gripar!”, e acontece exatamente como previmos: acordamos gripados. Com a alergia ocorre o mesmo, quando nos deparamos com uma sala empoeirada, já supomos que provavelmente os sintomas logo, logo vão aparecer. Podemos também utilizar esse raciocínio para as situações onde estamos mergulhados em um trabalho excessivamente desgastante e nos sobrevém a sensação de que não aguentaremos por muito tempo.

Podemos considerar que a doença faz parte da vida, aliás, não existe um único ser vivo (sendo humano ou não) que não adoeça em alguma época da vida. E também não é verdade que, em nosso caso (seres humanos), muitas vezes podemos nos utilizar dessa “antecipação” para evitar a situação adoecedora? Muitas vezes chegamos mesmo a mudar todo nosso estilo de vida para não sofrer as consequências de uma doença grave no futuro.

Se concordarmos que muitos adoecimentos são previsíveis, podemos afirmar: é muito importante saber em que

situações esses adoecimentos acontecem para que possamos evitá-los ou minimamente diminuir seu prejuízo sobre nossa vida.

Buscamos então, ao nos preocupar com nossa saúde, mudar nossos hábitos e o mundo que construímos ao agir, de modo que nossa vida seja menos prejudicada pela doença – e, para isso inventamos, testamos e reutilizamos o que já nos deixa mais fortes. Bem, dessa forma, toda a situação que atravessamos não passaria a ser diferente?

Que saúde é essa?

Se concordamos também com a constatação de que todo ser vivo adoece, temos que admitir que a vida desses seres não se limita à situação adoecedora. Por exemplo, se apresentamos um quadro de depressão, não podemos dizer que nossa vida inteira seja a depressão; tanto que procuramos ajuda para restabelecer uma condição que consideramos normal.

> [...] normalidade não relaciona-se com ter saúde completa, pois é um estado intermediário entre a sanidade e a doença, um compromisso aceitável em um dado momento, em um contexto histórico e social específico (BRITO; ATHAYDE; NEVES, 2003).

Podemos tratar os sintomas, como a fadiga e o desânimo, e podemos também tratar as causas da depressão, mas deixando essa reflexão para depois, o que gostaríamos de destacar aqui é a força e a disposição para transformar a situação adoecedora.

Se todos adoecem em determinado momento da vida, o que chamamos de saúde ou de uma vida saudável não pode deixar a doença de fora, como se o adoecimento jamais pudesse acontecer.

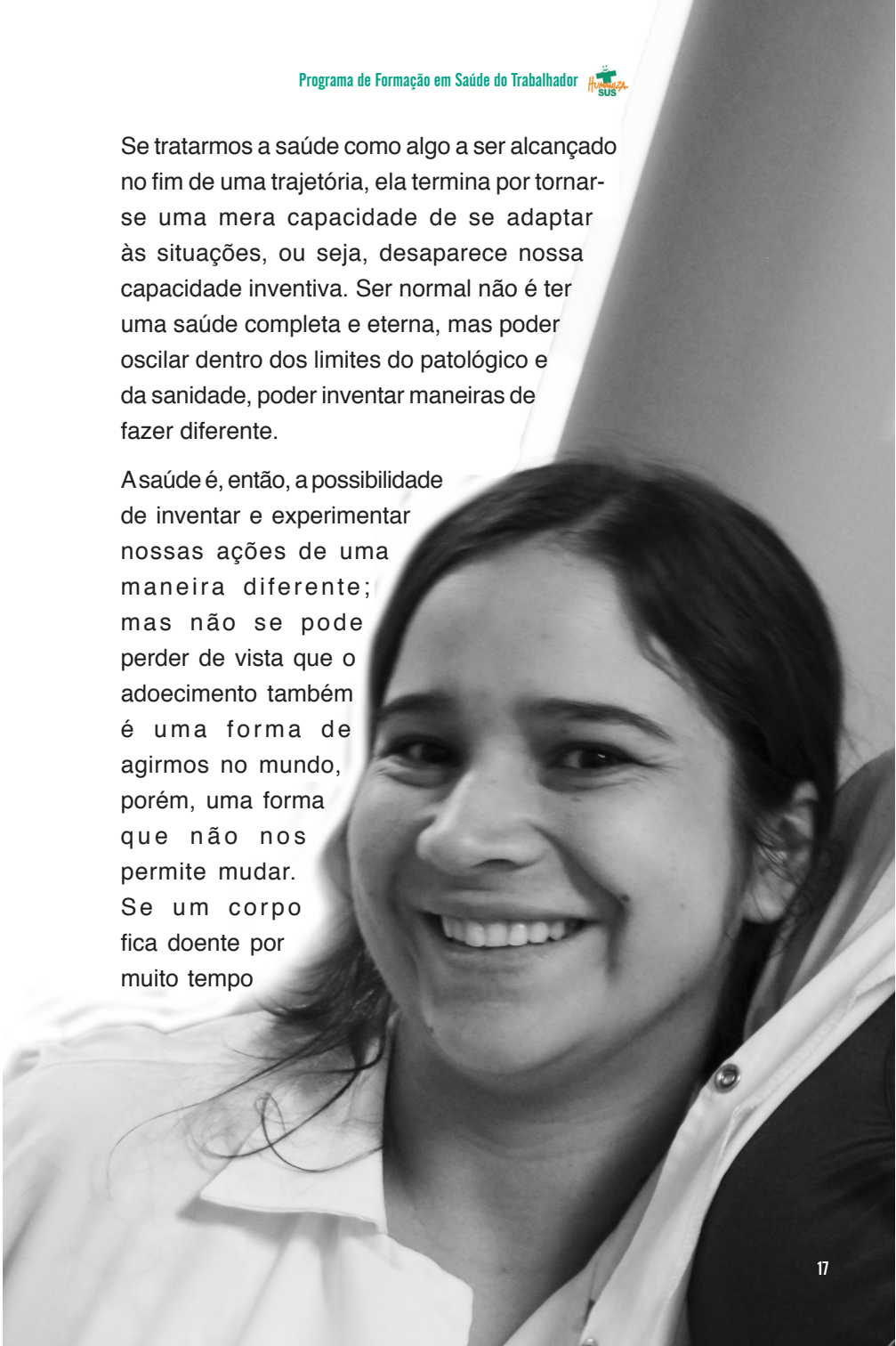
Mas o que chamamos de saúde, então? Se há algum sentido no que dissemos até aqui, vocês acham possível dizer simplesmente que saúde é o contrário de doença, ou que saúde/doença fazem referência somente ao funcionamento interno de um corpo?

Saúde, nesta perspectiva ampliada, não tem o sentido de ausência de doença, mas é a nossa possibilidade de criação/invenção de estratégias e saídas para as situações que levam ao adoecimento. Uma pessoa (ou um ser) doente imobiliza-se diante do obstáculo que se coloca à sua frente, se torna impossibilitada de criar novas normas de funcionamento onde se pode efetivamente experimentar uma vida mais saudável.

E quantas e quantas vezes não nos sentimos esgotados quando trabalhamos além da conta? Se for assim, o termo saúde diz respeito a algo além do funcionamento interno de um organismo, não é mesmo? Se consideramos que há situações adoecedoras e situações onde nos percebemos mais fortes e potentes para continuar vivendo, não podemos dizer que a doença ou a saúde é algo que acontece somente dentro de nós. Uma situação qualquer fala da forma como nos relacionamos conosco e com o ambiente que construímos ao agir no mundo. Logo, a forma como nos relacionamos ou nos organizamos para conviver é um fator de fundamental importância ao se pensar o tema saúde.

Se tratarmos a saúde como algo a ser alcançado no fim de uma trajetória, ela termina por tornar-se uma mera capacidade de se adaptar às situações, ou seja, desaparece nossa capacidade inventiva. Ser normal não é ter uma saúde completa e eterna, mas poder oscilar dentro dos limites do patológico e da sanidade, poder inventar maneiras de fazer diferente.

A saúde é, então, a possibilidade de inventar e experimentar nossas ações de uma maneira diferente; mas não se pode perder de vista que o adoecimento também é uma forma de agirmos no mundo, porém, uma forma que não nos permite mudar. Se um corpo fica doente por muito tempo



é porque não está conseguindo funcionar de uma maneira diferente, o que pode nos levar rapidamente para a morte. A saúde, por outro lado, é essa força que todo ser vivo possui para inventar outras formas de funcionamento e de relação consigo mesmo e com o mundo.

Existe mesmo alguma relação entre saúde e o modo como nos relacionamos com os outros e com o ambiente onde vivemos?

Para não perder de vista o foco do nosso texto, pensaremos com um pouco mais de calma a relação entre a saúde e o modo como nos organizamos para trabalhar (lembrando que o tema "trabalho" será melhor explorado no próximo texto). Quem se sente bem em trabalhar em um lugar onde tudo é imposto e onde todos os intervalos são vigiados? Pouquíssimas pessoas ou provavelmente ninguém responderá que se sente bem em um lugar assim, e isso acontece porque essas situações funcionam como a doença – a força e a disposição para transformarmos o que não está indo bem ou o que nos causa sofrimento são constrangidas se as relações que vivemos são autoritárias e muito duras. Se fizermos um mesmo movimento por muito tempo, sem a possibilidade de mudar de posição, provavelmente desenvolveremos uma séria doença ocupacional, não é verdade? Se vivemos em um ambiente sujo e mal cuidado não é grande a chance de que doenças contagiosas apareçam? E se pretendemos mudar essa situação não temos que limpar o ambiente e nos relacionar de uma maneira onde produziremos menos lixo?

Esses questionamentos são colocados aqui, para que possamos pensar na dimensão coletiva de nossas ações e sua relação com o tema "saúde", ou em outras palavras, que a saúde não é produzida por um único ser, mas ela nasce em nossas relações, no modo como essas relações acontecem. No caso do ambiente de trabalho, por exemplo, quando as relações são autoritárias podemos ver muitas pessoas descontentes e doentes, fato que revela uma estreita relação entre a forma como nos organizamos para trabalhar e a saúde dos trabalhadores. Muitas pesquisas e, principalmente, nossas experiências têm nos mostrado que quando não temos espaço para sugerir formas menos desgastantes para o trabalho, adoecemos rapidamente.

O que está em jogo quando buscamos um trabalho mais saudável?

A partir da nossa experiência cotidiana – no ambiente de trabalho (o mundo que construímos e habitamos ao trabalhar), por exemplo, – podemos afirmar que é impossível tratar de saúde (mesmo a nossa própria saúde) sem considerar as situações pelas quais passamos ou sem considerar as formas como nos organizamos para superar os adoecimentos, seja qual for a perspectiva de análise. Mas embora possamos afirmar tal relação, nos serviços de saúde ainda existem poucos espaços onde o tema (saúde) e as experiências sejam discutidas e compartilhadas; e como são pouco discutidas, foge-nos sua dimensão principal: a luta por melhores condições de trabalho é um exercício ético que aponta para uma avaliação permanente

das práticas e seus efeitos sobre nossas vidas. A não existência dos espaços de compartilhamento das histórias e dos sonhos coletivos tem nos levado a inúmeros outros problemas, como o trabalho desgastante, infraestrutura precária, burocratização das relações de trabalho, o valor atribuído ao(à) trabalhador(a) por parte da população e do governo, dentre muitos outros. Todos esses problemas acarretam consequências muitas vezes nefastas sobre a vida dos trabalhadores(as), e assim, tendo um espaço pequeno para estabelecer relações mais saudáveis terminam por adoecer.

Por outro lado, temos também no próprio SUS, experiências onde o "compartilhar experiências" e o "pensar conjuntamente" promovem um ambiente muito mais saudável. Se tratar de saúde é tratar também de nossas relações (em todas as instâncias – trabalhadores, usuários, gestores – sem que uma seja considerada mais importante que a outra), começamos, assim, por tecer uma rede viva que sustenta nossas ações; vamos lentamente substituindo o esforço individual de umas poucas pessoas, que logo, logo desistem por estarem doentes pelo trabalho desgastante.

Nossa proposta é, então, buscar uma compreensão mais ampliada do que chamamos de saúde e sua relação com as situações de trabalho, em conjunto com os(as) trabalhadores(as) do SUS, de modo que se caminhe em uma direção menos desgastante para o(a) trabalhador(a) – nos guiando sempre pelas experiências que têm promovido a saúde nesta perspectiva.

1. Como transformar as situações adoecedoras em nosso ambiente de trabalho, combatendo os sintomas ou

enfrentando e transformando as diversas causas que produzem essas situações?

2. No seu local de trabalho, você acha que há alguma relação entre os adoecimentos e a forma como as pessoas se organizam para trabalhar?

3. Você conhece algum local de trabalho onde os(as) trabalhadores(as) tenham conseguido se organizar de forma diferente para superar uma situação adoecedora?

Referências

BRITO, J.; ATHAYDE, M.; NEVES, M. Y. (Orgs.). **Caderno de método e procedimentos**. Programa de Formação em Saúde, Gênero e Trabalho nas Escolas. João Pessoa: Ed. Universitária UFPB, 2003.

CANGUILHEM, Georges. **O normal e o patológico**. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000.

3 TRABALHO E GESTÃO

Muito prazer! Meu nome é João e eu trabalho com...

Em geral todos nós falamos e discutimos sobre o trabalho durante boa parte do dia. Pensamos em trabalho grande parte de nossa vida. Nós nos apresentamos falando nossa profissão como algo que nos caracteriza e diz muito sobre nós.

Bom dia, meu nome é Maria e eu sou enfermeira do hospital X!

As revistas dizem que devemos buscar realização pessoal no trabalho. A cultura popular diz que o trabalho enobrece o homem, que Deus ajuda quem cedo madruga, que em vez de cantar devemos trabalhar como a formiga para sobrevivermos aos períodos de inverno. No entanto, poucas vezes a gente para para pensar sobre o trabalho, sobre o que é isso que nos ocupa durante tanto tempo, nos marca, nos dá prazer e nos faz sofrer. O que é o trabalho? O que é trabalhar? Quem é trabalhador?

Marx no início do século passado já dizia que o trabalho é uma atividade que transforma o meio e o homem simultaneamente. E acrescentava que trabalhar é uma exclusividade humana, só os seres humanos trabalham! Essa afirmação nos afasta da ideia do trabalho como simples força, da noção de força de trabalho, tão difundida e empobrecedora de uma atividade tão nobre. Podemos pensar no gado que gira a moenda, que puxa o arado; no cavalo que põe a carroça em movimento como força, mas nunca como trabalho, bem como não podemos comparar



com a atividade do lavrador que ara a terra ou com a dos catadores de papelão que puxam pequenas carroças pelas ruas das grandes cidades. Por mais que questionemos as condições, que muitas vezes consideramos desumanas, essas são atividades distintas. Como já nos dizia Marx:

> Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a abelha supera mais de um arquiteto ao construir sua colmeia. Mas o que distingue o pior arquiteto da melhor abelha é que ele figura na mente sua construção antes de transformá-la em realidade. No fim do processo do trabalho aparece um resultado que já existia antes idealmente na imaginação do trabalhador. (MARX, 2002)

Ou seja, o pior dos arquitetos distingue-se da melhor das abelhas pelo fato de que ele planeja o que vai fazer antes, e isso faz toda a diferença. Essa capacidade de antecipar o trabalho, de criar e planejar é que nos distingue e caracteriza o trabalho humano. No entanto, com o advento do modo capitalista de produção vimos um processo constante que tentou transformar o trabalhador em mais um dos recursos da indústria, reduzindo seu trabalho, esse processo criativo, em simples força, em mera execução de tarefa. Talvez a proposta taylorista de uma Organização Científica do Trabalho foi a que mais radicalizou essa tentativa propondo uma separação entre o trabalho de concepção e o de execução. Ou seja, dividiu o trabalho entre aqueles que pensam e aqueles que executam. Alguns conceberiam e prescreveriam o que deveria ser feito e outros realizariam o que estava definido na prescrição. Essa prescrição serve

para definir e orientar de uma maneira mais ou menos completa o que deve ser feito e a forma como deve ser feito. Com a prescrição pronta caberia aos demais trabalhadores apenas executá-la da forma e no ritmo estabelecido para um ótimo funcionamento da indústria.

Dizem que Henry Ford, um dos grandes empresários da indústria automobilística do século XX, falava que gostaria que seus operários deixassem o cérebro junto com o chapéu na entrada de suas indústrias. Ele queria um trabalhador que se resumisse a um corpo capaz de executar as tarefas prescritas. Será que para realizá-las esses trabalhadores não precisavam pensar? Será que eles agiam como máquinas? Isso é possível?

Essa forma de pensar o trabalho não se restringiu às fábricas, ele foi difundido pelos mais diferentes setores e influenciou a nossa forma de olhar o nosso trabalho, o trabalho em saúde. Quantas vezes nos deparamos com prescrições vindas de cima para baixo que determinam como realizar nossa atividade de trabalho? Quantas vezes prescrevemos o trabalho do outro? Lidamos e seguimos prescrições uma boa parte do tempo quando estamos trabalhando, mas não todo o tempo! Por outro lado, as prescrições também são importantes. Mas... como?

Prescrição ou invenção: que caminhos seguir?

Alguns pesquisadores ao analisar o trabalho perceberam que o que é realizado nunca coincide totalmente com o que foi prescrito. Por um lado, porque a prescrição nega ou subestima as diferenças e variações entre os trabalhadores e propõe a tarefa para um(a) trabalhador(a) médio(a)

inexistente, como se todos fossem iguais. Nega que esses sujeitos possuam características físicas e idades diferentes, histórias de vidas únicas, e que durante suas vidas são marcados por diferenças de gênero, etnia, classe social, religiosa, etc.

Além dessas diferenças entre os sujeitos, ainda podemos perceber que para dar conta do nosso trabalho precisamos inventar novas maneiras de efetivá-lo e, ao fazermos isso, também nos transformamos. Tanto nós como o nosso ambiente de trabalho estamos em constante transformação. Isso quer dizer que para conseguir realizar nosso trabalho somos levados a modificar a forma de fazê-lo todo tempo, no contato com o meio de trabalho, o modificamos, e o subvertemos com o intuito de dar conta dessas variabilidades, das infidelidades que se apresentam incessantemente. Transformamos e reinventamos constantemente os modos de trabalhar, nossa atividade, e a nós mesmos, sem o que seria impossível sua realização.

Então, o trabalho é constituído por um constante diálogo entre as prescrições e a necessidade de atualizá-las ou de criar novas formas de trabalhar. Nosso desafio aqui é evitar que um lado seja “mais valioso” que o outro, pois prescrição e experiência são duas faces da mesma moeda. Atuar somente em um desses extremos, já se mostrou ao longo da história prejudicial à saúde dos trabalhadores. Podemos ao invés de ter que escolher um desses lados, afirmar a importância desse diálogo e ressaltar que [...] os limites da normalização racional permitem reconhecer que é necessário “algo mais” para atingir a eficácia, realizar

o desempenho, enfrentar os acontecimentos (JOBERT, 2002). O trabalhador é impelido incessantemente a criar e produzir novos conhecimentos para que o trabalho se efetive neste mundo repleto de variabilidades, sem, entretanto, negar ou descartar a história daquele trabalho.

Na área de saúde essas variabilidades são muito visíveis, uma vez que além das diferenças entre os trabalhadores temos as diferenças entre profissões, entre os locais de trabalho (trabalhar em uma unidade de saúde é diferente do trabalho no hospital), entre as localidades em que se situam (hospital no Rio de Janeiro ou em Recife, na periferia ou numa área nobre). Além disso, o trabalho em saúde é marcado pelo contato com os usuários do serviço, uma vez que não podemos falar de um usuário padrão, ideal. Assim como os trabalhadores, os usuários possuem histórias de vidas diferentes, demandas e queixas específicas, valores e crenças diferentes.

E ainda que a existência de prescrições, protocolos e programas sejam fundamentais para a composição de um Sistema Único de Saúde eficiente e resolutivo, os trabalhadores do serviço devem no contato com o usuário ou com outro trabalhador, reformulá-los, recriá-los, de acordo com aquela situação específica. Estes encontros são sempre atravessados pelas crenças, valores, saberes, prescrições, protocolos e condições de trabalho que são anteriores ao encontro propriamente dito, por um conjunto de normas antecedentes (individuais e coletivas). Essas normas antecedentes são fundamentais para guiar a atividade dos trabalhadores, mas são modificadas diante das demandas e características do trabalho a ser desempenhado. A atividade

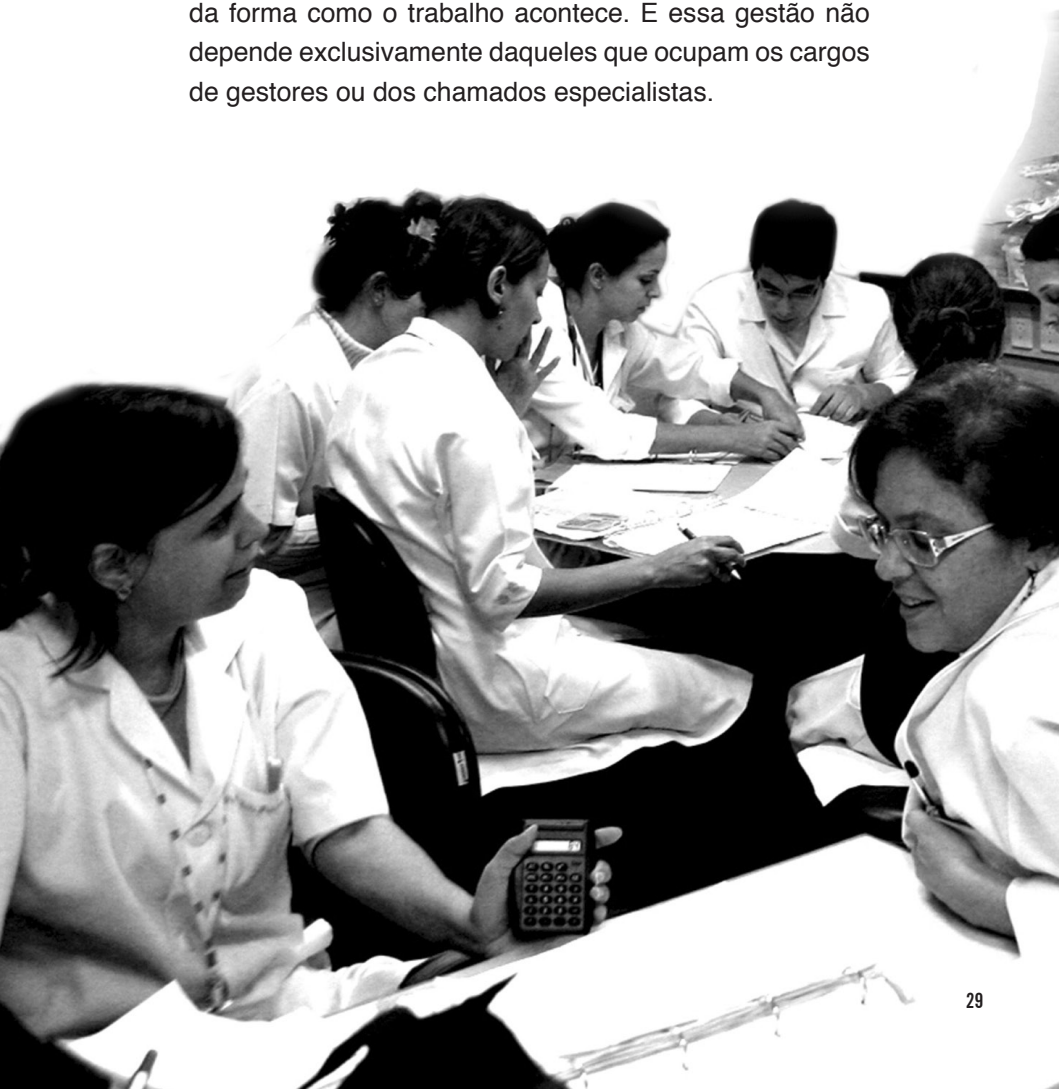
de trabalho sempre ocorre nesse jogo entre as normas antecedentes e as renormalizações, suas modificações e atualizações constantes.

Negociação e gestão: que história é essa?

A gente pode perceber que o trabalho não é de maneira alguma uma coisa simples, que exija simplesmente nossa força ou habilidade motora, o trabalho é extremamente rico e complexo. Você acredita que as indústrias Ford chegariam onde chegaram se os trabalhadores deixassem a inteligência junto com o chapéu na entrada? E vocês acham que podem trabalhar sem pensar, ou só repetindo o que foi determinado? Quando trabalhamos, negociamos o tempo inteiro com o que nossos colegas de trabalho pensam sobre a forma que devemos agir, com o que o usuário espera de nós, com o que os profissionais que ocupam os cargos de gestão definiram que devemos fazer e com os recursos disponíveis. Nessas negociações partimos do que acreditamos, queremos, achamos correto, mais confortável, mais rápido, mais fácil e que sabemos melhor como fazer. A cada uma de nossas ações cotidianas negociamos isso e muito mais.

Podemos constatar em nossa experiência cotidiana, que o trabalho é constituído por esse conjunto de negociações e por atividades compartilhadas que são exercidas por trabalhadores com saberes dos mais variados e experiências específicas. O trabalho na saúde, portanto, é submetido a essa regulação que se efetiva na cooperação entre os trabalhadores e os usuários, numa dinâmica que atravessa diferentes pontos de vista.

A esse processo de reinvenção/negociação permanente em nosso cotidiano de trabalho chamamos de gestão, pois o trabalhador é produtor de saberes, novidades e estratégias que fazem o trabalho acontecer. Portanto, o trabalhador também é gestor do processo de trabalho. Trabalhar é gerir e inventar. Gerir e inventar junto com os outros, pois a forma como nos organizamos para trabalhar não difere da forma como o trabalho acontece. E essa gestão não depende exclusivamente daqueles que ocupam os cargos de gestores ou dos chamados especialistas.




LEITO
24
LEITO
23

Então, também sou gestor do meu trabalho? De quem é a responsabilidade pelo meu sofrimento e pelo meu prazer no trabalho?

Sim, somos gestores do nosso trabalho. Nossa experiência de trabalho não significa submissão exclusiva às regras e normas prescritas, mas, sobretudo, negociação e criação. As situações constituídas por esses processos não revelam a gestão acontecendo em todos os aspectos do trabalho? Assim, pensar a gestão do trabalho no sistema de saúde implica não apenas em discutir o que é feito, mas também como ele é feito.

Como podemos verificar, essa gestão não acontece de maneira simples. Quando um trabalhador é obrigado a fazer o que não deseja, não acredita; quando não possui os meios disponíveis para realizar a atividade; quando as relações estabelecidas nos locais de trabalho constrangem a possibilidade de invenção, o que se experimenta é um aumento da sensação de desprazer e o trabalho se transforma em sofrimento. Agora, quando se consegue relacionar esses diversos fatores o sentimento é de satisfação, ainda que também possa ser acompanhado pelo cansaço. Quando um(a) trabalhador(a) de saúde consegue dar conta da demanda do usuário ou das determinações da prescrição a partir de princípios e valores compartilhados, utilizando os equipamentos e técnicas necessários e estabelecendo uma boa relação com os demais profissionais de sua equipe, ele(a) em geral não vai relatar sofrimento, mas uma sensação de prazer.

As condições e exigências de trabalho, a remuneração, as relações com os demais trabalhadores (da gestão ou não,

pois estamos falando de uma gestão compartilhada), com os usuários, são fatores que podem produzir sofrimento ou prazer. Ao tentar se restringir a um ou dois desses fatores corre-se o risco de ser reducionista. Assim, podemos pensar em termos das relações que se estabelecem num determinado hospital, unidade de saúde, equipe, etc., ao invés de tratar esse sofrimento ou o prazer como uma coisa dada. Você já ouviu falar de alguém que trabalha muito e é realizado profissionalmente? E alguém que não é exigido e reclama dizendo que sofre no trabalho?

Diante disso, podemos falar que o trabalho pode produzir adoecimento e saúde. Se entendemos a saúde como a capacidade de lidar com as variabilidades do meio e criar novas normas de vida, podemos afirmar que quando o trabalho limita essa capacidade a chance de adoecermos é maior. Ao se pensar a relação entre saúde, trabalho e gestão pelo ponto de vista apresentado, tratamos então de uma corresponsabilização, e não do esforço em se achar um culpado pelas experiências que vivemos.

É possível que o trabalho em saúde não produza adoecimento? O que temos feito para promover saúde em nossos locais de trabalho?

Temos duas notícias: uma boa e outra ruim. A boa notícia é que as pessoas produzem incessantemente estratégias para se defender da nocividade nos meios de trabalho e grande parte delas tem sucesso nessa empreitada, é por isso que mesmo sofrendo continuam trabalhando sem adoecer. A má notícia é que em geral, na atualidade, as formas de lutar contra o adoecimento se mantêm

no nível individual, cada um por si, e sabemos que as estratégias coletivas são muito mais eficazes. Os espaços de compartilhamento e socialização das experiências são cada vez mais restritos e assim as ferramentas para nos proteger vão enfraquecendo.

Essa constatação aponta para uma postura de não passividade diante das situações que atravessamos – a condição de saúde em nosso trabalho depende necessariamente da maneira como nos organizamos para trabalhar, ou da forma como gerimos coletivamente esse trabalho, portanto, depende também das escolhas e negociações que realizamos na atividade de trabalho.

Promover saúde nos locais de trabalho é aprimorar a capacidade de compreender e analisar o trabalho de forma a fazer circular a palavra, criando espaços para debates coletivos. A gestão coletiva das situações de trabalho é critério fundamental para a promoção de saúde. Trata-se de compreender as situações nas quais os sujeitos trabalhadores afirmam sua capacidade de invenção e de avaliação das regras de funcionamento coletivo instituídas no âmbito das organizações de saúde.

Além de promover saúde, a possibilidade de gerir coletivamente o trabalho no Sistema Único de Saúde (SUS) é um de seus pilares, haja vista que se trata de um sistema público, entendido como o que diz respeito a todos. Tornar a saúde pública significa, assim, não apenas ter garantido o acesso formal aos equipamentos destinados a esse fim, mas implica, também, a participação na definição da perspectiva de trabalho que se atualiza em cada unidade de saúde. Estamos falando de uma política pública que não

separa atenção de gestão dos processos de produção de saúde e que amplia a grupalidade, ou seja, das formas de comunicação intra e intergrupos nas unidades de saúde.

1. Quais são as prescrições que você encontra na sua função? Elas são suficientes?
2. O que você tem feito para lidar com as adversidades que se apresentam no trabalho? Você faz sozinho ou com outros trabalhadores?
3. Quais são as estratégias que você usou nos últimos tempos que considera eficazes? Você as compartilhou com os demais trabalhadores?

Referências

BRASIL. Ministério da Saúde.**Trabalho e redes de saúde**: valorização dos trabalhadores da saúde. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.

BRITO, J.; ATHAYDE, M.; NEVES, M. Y. (Orgs.). **Caderno de método e procedimentos**: programa de formação em saúde, gênero e trabalho nas escolas. João Pessoa: Ed. Universitária UFPB, 2003.

JOBERT, Guy. A inteligência no trabalho. In: CARRÉ, P.; CASPAR, P. (orgs.) **Tratado das ciências e das técnicas da formação**. Lisboa: Instituto Piaget, p. 223-240, 2001.

MARX, Karl. **O capital**: crítica da economia política: livro 1. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.

4 AS COMUNIDADES AMPLIADAS DE PESQUISA (CAP)

Fabíola Botechia
(Colaboradora)

Breve histórico da luta dos trabalhadores pela saúde

Encontramos na história algumas experiências da luta por ambientes de trabalho mais saudáveis, pela mudança de tudo aquilo que incomoda nesses locais. Dentre elas, ganha destaque, na década de 70, um importante encaminhamento no movimento sindical italiano que ficou conhecido como “Modelo Operário Italiano de luta pela saúde” (MOI).

Nessa época, ao mesmo tempo em que ocorria um crescimento socioeconômico, pleno emprego e aumento da produção, aconteceu um aumento da desqualificação, baixos salários, desgaste dos trabalhadores. Esses grupos de trabalhadores solicitaram a um grupo de profissionais da área da saúde maiores informações sobre os riscos que suas condições de trabalho poderiam representar para a saúde. A partir de uma das iniciativas de grupos de operários, constituiu-se então um coletivo formado por “técnicos”, operários e sindicalistas que colocavam juntos em análise a organização do trabalho e a nocividade da fábrica. O objetivo de reunir tais informações era de que esse conjunto de dados pudesse se transformar em instrumento de luta pelas mudanças nas condições de trabalho consideradas nocivas.

Um novo modelo de produção de conhecimento é encaminhado por este grupo, formulando, assim, outro tipo de relação entre saberes "formais" dos pesquisadores (acadêmicos/científicos) e saberes "informais" dos trabalhadores e que aparece como uma nova forma de se fazer pesquisa, denominada de **Comunidade Científica Ampliada (*CCA*)**. Ao invés de ignorar e/ou desqualificar a experiência dos trabalhadores, é necessário socializar as descobertas científicas, colocando-as em diálogo com o saber operário, tendo como ponto de partida a pesquisa sobre o local de trabalho.

No Brasil, influenciados pela experiência italiana, um grupo de pesquisadores inicia um projeto de pesquisas sobre a problemática da saúde dos(as) trabalhadores(as) em uma área diferente da nossa, nas escolas públicas. Esse projeto tinha por objetivo compreender a relação entre o trabalho e os processos de saúde-doença, numa perspectiva de transformar as situações consideradas nocivas. Assumindo e afirmando que o trabalho é elemento central na produção do processo saúde-doença e, consequentemente, que a transformação do trabalho é fundamental para a conquista da saúde.

Uma das pesquisas denominada *Programa de Formação em Saúde, Gênero e Trabalho nas Escolas* tinha como proposta formar "trabalhadores" em Saúde, Gênero e Trabalho para o monitoramento e acompanhamento das relações entre saúde e trabalho nas escolas públicas, sob o ponto de vista dos protagonistas da atividade.

A proposta assumida era a de buscar um modo de produção de saberes a partir da constituição e do desenvolvimento de

um espaço de diálogo entre os profissionais de pesquisa e os trabalhadores. Buscava-se compreender as condições e as dinâmicas que podem gerar o sofrimento e conduzir ao adoecimento, bem como as estratégias que esses trabalhadores criam no seu dia a dia de afirmação de saúde e de vida.

Inspirados na expressão **Comunidade Científica Ampliada**, estes pesquisadores preferiram denominar o espaço no qual poderia se constituir essa rede de informações, troca de experiências e construção de outras estratégias coletivas, por outra expressão: **Comunidade Ampliada de Pesquisa (*CAP*).**

Mas, qualquer um pode falar de saúde?

O ser humano é capaz de criar novas normas (e seu próprio meio). Logo, não se pode supor uma pura passividade diante das modificações experimentadas. É a própria vida que institui normas e luta contra os perigos que a ameaçam. Assim, a vida dita as normas que lhe permitem manter-se e crescer.

Os seres humanos possuem a capacidade e a possibilidade de ora situar-se no polo da saúde, ora no polo da doença. Esses dois polos, contudo, não estão numa relação de exclusão ou de eliminação, mas constituem-se como formas possíveis e diferentes de vida. Este caráter de plasticidade do vivente é que nos permite compreender como um mesmo homem, em momentos diferentes, pode ser considerado sadio ou doente.

Ou seja, em qualquer situação de trabalho, o trabalhador confronta-se com os limites e equívocos da prescrição, com as exigências/constrangimentos, com as variabilidades, com o acaso, bem como faz escolhas, a partir de debates de valores e de normas, podendo produzir desvios para realizar a tarefa.

Ou seja, em qualquer situação de trabalho, o trabalhador cotidianamente é confrontado com as surpresas, dificuldades, censuras, insatisfações, e também, todos os dias, para dar conta do trabalho, inventa e busca alternativas para realizar as atividades.

Assim, os trabalhadores sentem os efeitos que o trabalho pode produzir, como por exemplo, a ausência de pausas, o ritmo e o tempo de trabalho, a rotina, o excesso de atendimentos, etc. Esses efeitos somente o trabalhador pode sentir e, consequentemente, também somente ele será capaz de falar, compreender e transformar a realidade.

Nessa direção, entende-se que os trabalhadores podem produzir conhecimento (não científico, mas nem por isso inferior, pois não se trata de hierarquizá-los) com a sua experiência – e o fazem com frequência. Estar atentos às relações estabelecidas nos meios de trabalho – queixas, acidentes, doenças, ações – passa a ser um exercício cotidiano para que se possa organizar um processo de produção de conhecimento que contribua para a transformação da realidade.

Conseguir identificar o que está indo bem e o que está indo mal no espaço de trabalho, para si mesmo, para os colegas, para os alunos, para a comunidade; torna-se, assim, um exercício fundamental e permanente para melhor compreender e transformar a relação saúde-trabalho.

Mas, qualquer um pode fazer pesquisa?

A mudança do termo “científico” pelo de “pesquisa” não foi à toa. A proposta é de que cada área de conhecimento, cada polo possa contribuir com seu saber, estabelecendo-se uma investigação em parceria.

Tal proposta contempla tanto a formação em parceria entre os diferentes saberes, quanto a pesquisa-intervenção, enfim, uma formação para a ação e na ação, na perspectiva de luta pela saúde e afirmação da vida. Organizado em ciclos, que têm por objetivo uma multiplicação permanente. Esse processo pretende ampliar o olhar e a escuta dos trabalhadores para os problemas do SUS em relação à saúde, bem como possibilitar a invenção/construção de saídas para tal situação.

Estar atento àquilo que nossos colegas falam, àquilo que nosso próprio corpo fala, e também àquilo que outros profissionais conseguem perceber, nos permite melhor compreender a realidade e possivelmente criar estratégias de mudança. Conhecer uma realidade da qual já estamos íntimos, exige um esforço a fim de aprimorar nossos sentidos. Exige esforço mesmo! Inventar e socializar as estratégias de luta é uma das tarefas da Comunidade Ampliada de Pesquisa.

Percebemos, então, que o instrumento da **Comunidade Ampliada de Pesquisa** é, essencialmente, participativo. Aqui, o trabalhador estabelecendo parcerias constitui-se como ator ativo no processo de investigação sobre a questão da saúde. O objetivo é que cada trabalhador torne-se também um multiplicador desse conhecimento,

aumentando a rede de informações e experiências sobre o trabalho.

Multiplicar o quê? De que forma?

Vimos que cada um de nós pode e deve falar do que sente no trabalho – alegrias, insatisfações, tristezas, desapontamentos, etc. Além disso, vimos também, que devemos exercitar nossa capacidade de escuta do outro – também ele cheio de reclamações, elogios, propostas. A ideia colocada é de que cada um de nós é sujeito ativo de um processo de investigação sobre os assuntos relacionados à saúde e ao trabalho; bem como a de que as mudanças efetivas não acontecem – ou pelo menos não deveriam exclusivamente – a partir de decisões externas, dos dirigentes, do governo ou da universidade.

Cada trabalhador que participar desse processo deverá: apropriar-se dos conceitos apresentados, realizar estudos sobre sua realidade, socializar suas produções e debatê-las nos encontros da Comunidade Ampliada de Pesquisa.

Essa proposta de formação tem como perspectiva que o formador – nesse caso denominado "profissional de pesquisa" – ao ser colocado à prova pelas situações reais trazidas pelos trabalhadores amplia também seus saberes. Na medida em que as situações de trabalho convocam o saber do formador, esses saberes precisam ser validados e confrontados na experiência concreta continuamente.

Compreendido como um processo de diálogo crítico permanente, o processo de formação dos multiplicadores não se limita a ser um momento de transmissão de

informações, de conhecimentos, mas antes um momento de escuta e de abertura de cada um para o outro parceiro do diálogo. Essa abordagem dialógica do Programa enfatiza as diferentes vozes que compõem qualquer diálogo, fazendo um convite de aceitação do outro, legitimando e reconhecendo a validade do saber do outro, explicitando a riqueza da experiência e do saber desse outro.

Isto implica no reconhecimento do outro como seu semelhante, como alguém com quem aprendemos coisas sobre o que ele faz e porque faz, bem como seus valores. Os trabalhadores precisam dos conhecimentos que são produzidos pelas diferentes disciplinas para valorizar seus saberes específicos, bem como para transformar sua situação de trabalho. Em contrapartida, tais disciplinas só podem se desenvolver a partir das questões trazidas pelo mundo do trabalho.

Então, com a CAP podemos mudar o que desejamos nos ambientes de trabalho?

Favorecendo e apostando na construção de espaços de diálogo, de debates, de confrontação entre os diferentes saberes, a **Comunidade Ampliada de Pesquisa** pode facilitar e ajudar no processo de investigação sobre a relação entre saúde e trabalho. Afirmando a perspectiva de que o ser humano, no encontro e no diálogo com o outro, constitui a si e ao mundo, será também nesse mesmo movimento que poderá encontrar formas de transformação da realidade.

A **Comunidade Ampliada de Pesquisa** tem por objetivo associar pesquisadores profissionais e trabalhadores numa

relação dinâmica e cooperativa de análise das situações de trabalho. De fato, essa relação de coanálise assume a perspectiva de que o outro possui um patrimônio importante para a compreensão da atividade e será preciso colocar em debate, e em circulação as informações e percepções acerca da sua própria atividade.

A potencialidade de transformação da realidade proporcionada pela CAP configura-se na ampliação da escuta e da visão do outro como alguém capaz de colaborar na compreensão da realidade. Um novo modo de perceber o cotidiano vivido, isto é, o que antes era considerado natural, simples, fácil, ganha novos sentidos. Nessa perspectiva, pode provocar e produzir mudanças, na medida em que passamos a analisar a própria atividade de trabalho. Multiplicando a experiência de investigação, de análise, de descoberta, de debate, poderá ser possível enriquecer a própria experiência.

As mudanças que poderão vir a acontecer são decorrentes da discussão, do debate, do confronto de ideias, dos diferentes pontos de vista, enfim, do movimento de luta e de vida. Esse movimento pode ser disparado com a constituição de um espaço onde os diferentes saberes podem entrar em diálogo, em interação, cada qual contribuindo para detectar, perceber, compreender e transformar uma realidade nociva. A esse espaço de diálogo, a esse encontro, denominamos, então, **Comunidade Ampliada de Pesquisa**.

1. Quais poderiam ser os nossos temas de pesquisa a respeito das relações e das condições do nosso trabalho?

2. Como construir uma comunidade ampliada de pesquisa no meu local de trabalho? Que dificuldades encontraríamos? Que facilidades encontraríamos?

Referências

BOTECHIA, Fabíola. **O desafio de compreender-desenvolver um regime de produção de saberes sobre o trabalho e suas relações**: a comunidade ampliada de pesquisa, 2006. Dissertação de Mestrado em Psicologia Social. Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, Brasil.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Trabalho e redes de saúde**: valorização dos trabalhadores da saúde. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.

BRITO, J.; ATHAYDE, M.; NEVES, M. Y. (Orgs.). **Caderno de método e procedimentos**: programa de formação em saúde, gênero e trabalho nas escolas. João Pessoa: Ed. Universitária UFPB, 2003.

ISBN 978-85-334-1838-7

Ouvidoria do SUS
136

Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde
www.saude.gov.br/bvs

SUS Sistema Único de Saúde

Ministério da **Saúde**

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA